

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تغذية الحامل والمرضع

(Nutritional Care Of Pregnant & Lactating Women)



تغذية الحامل والمرضع (Pregnancy and mother) **Feeding of mother**

- ❑ Extra allowances of nutrient and energy are necessary during the latter half pregnancy and through out lactation to satisfy : تلبية

1. Physiological requirement of pregnancy and lactation need of the fetus and nursed baby رعاية الطفل.

❑ Special feeding requirement : الاحتياجات الغذائية الخاصة :

1. Food material as; مواد غذائية مثل

- Powder milk الحليب الجاف and cheeses. الجبن

2. Medicinal preparation if necessary ;

- Iron- calcium- vitamin D- poly vitamin /minerals according need.



تغذية الحامل والمرضع

(Nutritional Care Of Pregnant & Lactating Women)

إن اهتمام الأم بصحتها وتغذيتها قبل وخلال الحمل ضروري لصحتها وقدرتها على الإنجاب، وبخاصة أن الفترة الإنجابية تضع الأم تحت حاجة الغذاء الكامل المتوازن لتغطية العديد من الوظائف الفسيولوجية الهامة، وكذلك لتكوين الجنين ونموه ولتكوين أنسجه جديدة أثناء الحمل ولتكوين الحليب اللازم أثناء الرضاعة.

احتياجات الحامل والمرضع Requirement Pregnant & Lactating

- تزداد احتياجات الحامل و المرضع من الطاقة والعناصر الغذائية وذلك لتغطية العديد من الوظائف الفسيولوجية الهامة في هذه المرحلة وفيما يلي استعراض لأهم الاحتياجات:

الطاقة Energy:

تزداد مقررات الطاقة بمقدار (٣٠٠ كيلو سعر/يوم) أثناء الحمل وبمقدار (٥٠٠ كيلو سعر/يوم) للمرضعات.

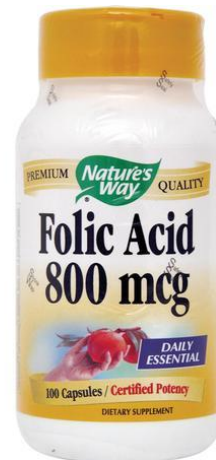
البروتين Protein:

تزداد المقررات اليومية من البروتين للمرضع بمعدل (١٥ غرام) ، كما تحتاج الحامل إلى كميات إضافية بمعدل (١٠ غرام)، وأهم المصادر الغذائية بالبروتين (اللحوم، الدواجن والأسماك والبيض، منتجات الألبان، البقوليات، الجوزيات والمكسرات).

العناصر المعدنية Elements mineral:

- تزداد الحاجة لجميع العناصر الغذائية في أثناء الحمل والإرضاع، لتصبح في ذروتها خلال الثلث الثالث من الحمل، حيث تحتاج الحامل الكالسيوم والفسفور لتغطية حاجة الجنين منها حيث يحتاج الجنين إلى ما لا يقل عن (٣٠٠ ملغم/ يوم) لذا فإن مقررات الحامل من الكالسيوم تصل إلى (١٢٠٠ ملغم/يوم).





❑ Effect of mal nutrition ; تأثير سوء التغذية ;

➤ On the mother الام ;

1. General impairment of health .
2. Contributes to some material hazard. يساهم في مخاطر الامومة.
3. Nutritional anemia: as;
 1. iron deficiency. نقص الحديد
 2. macrocytic anemia . فقر الدم الكلي
 3. osteomalacia هشاشة العظام and other deficiency problem .

➤ On the fetus ;

1. Low birth weight .
2. Premature onset of labor with the risk of birth injury.
3. Deficient body stores where the infant is susceptible to deficiency early in life especially iron – deficiency anemia and rickets.

التغذية المصاحبة لمتاعب الحمل:

- قد تعاني الحامل من بعض متاعب الحمل الأول خاصة في ساعات النهار الأولى، وقد يمتد إلى بقية ساعات اليوم مصحوباً بالقيء أحياناً، وقد يكون ذلك بسبب الاضطراب في الإفرازات الهرمونية في بداية الحمل،

وللتخفيف من هذه المشاكل يمكن اتباع ما يأتي:

١. تناول السوائل بين الوجبات وليس معها، خاصة في الصباح الباكر.
٢. تقليل كمية الطعام المتناولة في كل وجبه، مع زيادة عدد الوجبات (حوالي ٦ وجبات)
٣. تجنب الأطعمة الدسمة المقلية والمتبلة.
٤. تأخير وجبة الفطور وتناول الأطعمة سهلة الهضم.

الحموضة (Heart Burn)

- تظهر هذه الحالة في الأشهر الأخيرة من الحمل، وتزداد أعراضها بعد تناول الطعام أو عند الانحناء إلى الأمام، وللتخفيف من هذه المشكلة تنصح الحامل بما يأتي:

١. تناول الطعام في ببطء مع المضغ الجيد.
٢. زيادة عدد الوجبات مع تقليل كمية الطعام في الوجبة الواحدة.
٣. تجنب الأطعمة المقلية والبهارات.
٤. رفع رأس السرير قليلاً مما يقلل من رجوع الحمض المعدي إلى المريء.

■ الإمساك (Constipation)

- يحدث نتيجة زيادة إفراز هرمون البروجسترون الذي يقلل من الحركة (الدودية) للأمعاء مما يؤدي بالتالي إلى الإمساك، كما إن قلة الحركة لدى الحامل وضغط الرحم على الأمعاء من الأسباب المحتملة لحدوث الإمساك عندها، وللتغلب على الإمساك ننصح الحوامل بما يأتي:

١. زيادة تناول السوائل.

٢. زيادة تناول الأغذية الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة، الفواكه، الخضراوات والبقوليّاتيات.

٣. القيام ببعض التمارين الرياضية.

■ الوذمة (Edema)

- تكون الوذمة المرافقة للحمل (بخاصة في الأسابيع الأخيرة) أمراً طبيعياً ناتجاً عن زيادة حجم الدم، مما يؤدي إلى احتباس السوائل في الأطراف، وهذا عادة لا يتطلب تقليل الصوديوم والسوائل في الغذاء، وينصح بإتباع نظام غذائي متوازن، كما لا تحتاج الحامل إلى تناول أدوية مدرّة للبول إلا بعد استشارة الطبيب وتنتهي الوذمة عادة بانتهاء الحمل، أما إذا تطورت هذه الحالة إلى ما يعرف بتسمم الحمل فإنها تكون بحاجة إلى إشراف طبي.

الإرشادات الغذائية للأم الحامل:

- اتباع نظام غذائي متوازن والابتعاد عن العادات السيئة في الغذاء.
- التنوع الغذائي بتناول الأغذية التي تمثل المجموعات الغذائية الأربع.
- المحافظة على الزيادة الطبيعية في الوزن.
- الاعتدال في تناول المنبهات (الشاي والقهوة).
- الإمتناع عن التدخين والابتعاد عن الأماكن التي يتم فيها التدخين.



سوء التغذية لدى الحوامل Mal nutrition of pregnancy :

- إن أهم أمراض سوء التغذية التي تحدث للحامل بسبب عدم التنوع في الغذاء والتركيز على تناول نوع معين في أثناء فترة الحمل، مثل المخللات، البوظة مما ينتج عنه الأمراض التالية:

■ فقر الدم الناتج عن عوز الحديد (Iron Deficiency Anemia):

ولمعالجة هذا الفقر يجب اتباع ما يلي:

١. التركيز على تناول الاغذية الغنية بالحديد (مثل: السبانخ، العدس، الكبد).
٢. تناول الحمضيات التي تحتوي على فيتامين (ج) مما يساعد على امتصاص الحديد.
٣. تناول أقراص الحديد بعد استشارة الطبيب.



■ النقص التغذوي للكالسيوم وفيتامين (د):

- تزداد الحاجة لهذين العنصرين خلال فترة الحمل، حيث يؤدي النقص إلى حدوث ليونة في النسيج العظمي مع سهولة التعرض للكسر، لذا يجب زيادة تناول مصادر الكالسيوم وفيتامين (د) مع إعطاء أقراص الكالسيوم وفيتامين (د) تحت إشراف طبي.

السمنة وزيادة الوزن Obesity and increase weight :

إن زيادة الوزن في أثناء الحمل أمر طبيعي، إذ يتوقع أن يزداد وزن الحامل (١١.٣ - ١٥.٨) كغم تقريباً في نهاية الشهر التاسع، حيث يكون هناك زيادة في الوزن للأسباب التالية:

١. (وزن الجنين) (٣.٢ - ٣.٦) كغم.
٢. (المشيمة والسائل الأمنيوسي) (١.٦ - ٢.٥) كغم.
٣. زيادة وزن الرحم (١.١ - ١.٣) كغم.
٤. زيادة وزن الصدر (٠.٤٥ - ٠.٦٧) كغم.
٥. زيادة حجم الدم (١.٣٦ - ٢) كغم.
٦. ماء (١.٨ - ٢.٧) كغم
٧. زيادة النسيج الدهني (١.٨ - ٢.٩) كغم





الشكر والتقدير

إعداد د/ خالد مجاهد الحوالي